Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Não-Me-Toque

Rua Padre Valentim Rumpel, 220 - Bairro: Centro - CEP: 99470000 - Fone: (54) 30469890 - Email: frnaometoqvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000609-56.2021.8.21.0112/RS

AUTOR: ARI PAULO SCHMITT

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - Relatório (art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil).

ARI PAULO SCHMITT, qualificado na inicial, ajuizou *ação ordinária com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento* em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, igualmente qualificado, aduzindo que foi diagnosticado com Adenocarcinom de Próstata, estagio clínico IV, patologia codificada sob CID 10 C61. Referiu que, desde o diagnóstico da doença, tem se submetido a diversas linhas de tratamento indicadas a cada fase da doença. Assinalou que, no ano de 2019, diante do aparecimento de novos sintomas, foi diagnosticado com metástases ósseas e o aumento persistentes de seu PSA, motivo pelo qual necessita fazer uso do fármaco Enzalutamida (nome comercial xtandi), na quantidade de 04 cápsulas, uma vez ao dia. Ressaltou que o medicamento somente foi prescrito após várias linhas de tratamento experimentadas, bem como que a eficácia do fármaco resta comprovada pela sua inclusão em Diretriz Diagnóstica e Terapêutica – DDT, por orientação do CONITEC. Pontuou que a utilização da medicação é urgente e necessária, pois sua ausência pode acarretar até mesmo em perigo de vida ao demandante. Afirmou não ter condições financeiras de custear a medicação. Fundamentou juridicamente o pedido. Requereu a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que a parte demandada seja compelida a fornecer, imediatamente, o fármaco pleiteado. No mérito, requereu a procedência do feito para, com a confirmação da tutela provisória de urgência, condenar o réu ao fornecimento do fármaco ENZALUTAMIDA (nome comercial XTANDI)- 04 capsulas 01 vez ao dia. Pugnou a concessão da gratuidade judiciária. Anexou documentos (Ev. 1).

Recebida a inicial, concedida a antecipação de tutela e ordenada a citação da parte ré para oferecer contestação (Ev. 3).

Citado (Ev. 6), o réu ofereceu contestação (Ev. 16). Em preliminar, sustentou que a incumbência do tratamento em questão não cabe ao Estado, pois de disponibilização pelos CACONs, com responsabilidade da União. Argumentou a ilegitimidade passiva do Estado com responsabilidade exclusiva da União. No mérito, ressaltou que o tratamento do câncer é feito pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs. Frisou que a parte autora já estava recebendo atendimento junto ao Hospital de Caridade de Carazinho, credenciado junto à rede pública para fornecimento de tratamento oncológico. Pleiteou o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, ou, alternativamente, a improcedência. Anexou documento.

Houve réplica (Ev. 21).

Intimadas as partes para que dissessem sobre o interesse na produção de outras provas (Ev. 22), a parte ré requereu a produção de prova documental (Ev. 26), cujo pedido restou acolhido pelo Juízo (Ev. 30).

Aportou aos autos resposta ao ofício remetido ao Hospital de Caridade de Carazinho (Ev. 38).

Intimadas acerca da resposta anexada aos autos, a parte autora silenciou (Ev. 44) e a parte ré postulou pela expedição de novo ofício ao Hospital de Caridade de Carazinho.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

PASSO A DECIDIR.

II - Fundamentação (art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil).

<u>Do pedido de expedição de novo ofício ao Hospital de Caridade de Carazinho</u>

Procedida a abertura da fase de instrução, o Estado do Rio Grande do Sul requereu a expedição de ofício ao Hospital de Caridade de Carazinho, entidade responsável pelo atendimento da parte autora, a fim de requisitar informações acerca do valor da APAC referente ao tratamento oncológico do paciente Ari Paulo Schmitt, bem como sobre o montante dos valores que já foram e/ou ainda serão repassados pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE para o tratamento oncológico e custo do tratamento até então apurado com o referido paciente.

Deferido o pedido apresentado, sobreveio aos autos resposta do Hospital de Caridade de Carazinho/RS, onde restou informado que o valor mensal da APAC, repassado desde maio de 2020 até setembro de 2021 é de R$ 1.512,15, totalizando R$ 25.706,55, compreendendo o uso de medicamentos como Ondansetron, decadron, cimetidina, alegra, docetaxel, prednisona, zometa e eligard (evento 38, RESPOSTA1).

Intimado, o Estado do Rio Grande do Sul postulou a expedição de novo ofício ao Hospital de Caridade de Carazinho, a fim de que o Hospital de Caridade de Carazinho/RS preste contas acerca dos valores até então utilizados pelo paciente.

Com efeito, em que pese a pretensão veiculada pelo Estado na manifestação do Ev. 43, tenho que é caso de indeferimento do pedido de nova expedição de ofício. Isso porque o objeto da presente demanda é tão somente verificar o direito da parte autora ao recebimento do fármaco pleiteado na inicial. Assim, a destinação dos recursos pelo Hospital de Caridade de Carazinho é matéria que transborda ao objeto do presente feito e, caso a parte demandada entenda pela necessidade de maiores esclarecimentos, deve ser discutida em ação autônoma.

Portanto, indefiro o pedido apresentado ao Ev. 43.

Da Preliminar

Refuto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado do Rio Grande do Sul.

A parte autora ingressou com o presente feito visando a dispensação pelo réu do medicamento Enzalutamida, sendo deferido tal pedido pelo juízo. E, embora o Estado alegue a responsabilidade da União, que dispensa tratamento oncológico através dos CACONs, isso não afasta a sua responsabilidade solidária em fornecê-lo.

É sabido que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes de maneira solidária, independentemente do medicamento constar na lista de um deles apenas, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva de determinado ente. É dever dos Estados, modo solidário com os demais entes da Federação (Municípios e União), fornecer o(s) medicamento(s) postulado(s) pela parte autora, já que o direito à saúde, como essencial que é e outorgado pela Constituição Federal de modo universal, há de ser atendido de plano, sendo de eficácia imediata a regulação constitucional.

Em se tratando de responsabilidade solidária, pode a parte requerente demandar contra quaisquer dos entes, seja União, Estado ou Município e, no caso de condenação ao final, o ente poderá buscar ressarcimento com a União administrativamente ou em demanda própria, se assim preferir.

Ainda, o fato de o medicamento não constar na lista do Estado, de forma alguma serve para elidir sua legitimidade no presente feito, já que a saúde não pode estar limitada por uma lista formulada pelo Estado/Município para atender casos mais genéricos.

Nesse sentido, há julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *APELAÇÃO. ECA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO "A QUO". DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO A SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ADEQUADA AO TRATAMENTO. Pedido. Caso em que o menor, com dois anos e nove meses de idade quando ajuizada a ação, postula o fornecimento de procedimento cirúrgico, pois portador de CATARATA MONOCULAR NO OLHO DIREITO (CID 10 H 26.0). APELO DO MUNICÍPIO Não conhecimento do recurso. Caso em que o Município não recorreu de decisão do juízo "a quo" que não conheceu do recurso de apelação interposto. Assim, preclusa esta decisão é de rigor o não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Gravataí. APELO DO ESTADO Preliminarmente: Legitimidade passiva e Solidariedade. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. No mérito: Direito à saúde e Prescrição médica adequada ao tratamento. A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ponto de vista constitucional, é bem de ver que em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa ao princípio da legalidade. Por fim, os documentos médicos já constantes dos autos são suficientes para comprovar a necessidade do menor em receber o procedimento cirúrgico pleiteado. NÃO CONHECERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. (Apelação Cível Nº 70063112403, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 12/02/2015 - grifei)*
>
> *AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Litisconsórcio necessário com a União. Inocorrência. Cabe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. In casu, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Município para figurar no polo passivo da presente demanda, condenando-o, solidariamente, ao fornecimento do fármaco ora pleiteado. Responsabilidade pelo fornecimento de tratamento para o câncer. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade - sob pena de arcar com os custos do tratamento -, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). Custas e despesas processuais. Nos termos do artigo 11, do Regimento de Custas (Lei nº 8.121/82, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010), está a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas e emolumentos, devendo, no entanto, arcar com as despesas, salvo as oriundas de Oficial de Justiça, nos termos da ADIn Nº 70038755864. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70063108153, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 25/02/2015 - grifei)*

Outrossim, o fato de existirem Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs e UNACONs) mantidos pela União Federal não afasta a responsabilidade dos demais entes públicos (REsp n.º 1182710, Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado em 18/03/2010; REsp n.º 1097942, Ministro LUIZ FUX, publicado em 13/11/2008), orientação que prevalece neste Tribunal: AI Nº 70034454843, SANDRA BRISOLARA MEDEIROS; AC nº 70031543200, FRANCISCO JOSÉ MOESCH; e Agravo nº 70034726943, CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO).

Neste mesmo sentido o STJ, relativamente ao fornecimento do medicamento para câncer, em caso específico de tratamento de câncer de mama, já decidiu, *verbis*:

> *PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. TRASTUZUMABE (HERCEPTIN). PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA (CID 10). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 196. COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A matéria em discussão foi analisada pelo Tribunal a quo sob o enfoque constitucional, levando-se em consideração o Direito à Saúde, descabendo a esta Corte Superior o exame da controvérsia, sob pena de invasão da competência do STF. 3. Quanto à responsabilidade de cada ente público, percebe-se que o entendimento da Corte de origem está em conformidade com o do STJ, de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1561510/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 31/05/2016).*

Diante disso, afasto a preliminar arguida pelo réu e reconheço sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

<u>Do Mérito</u>

No que diz respeito ao mérito, analisando detidamente os autos, tenho que procede a pretensão autoral.

O artigo 196 da Constituição Federal ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, dever este que vem corroborado também no artigo 198, §1º, e no artigo 23, inciso II, da Carta Magna, bem como no artigo 241 da Constituição Estadual:

> *"**Art. 23.** É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;*
>
> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 198. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. **(<u>Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000</u>)."***
>
> *"**Art. 241.** A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação."*

Além disso, a saúde é direito fundamental, elencado dentro dos direitos sociais (artigo 6º, *caput,* da Constituição Federal[1]), e, assim, possui aplicação imediata e incondicionada, na forma do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, dispositivo que a ela se estende.

Portanto, é plenamente possível exigir de todos ou de qualquer um dos entes (União, Estado ou Município) - que possuem responsabilidade solidária – os medicamentos nos casos de extrema necessidade e por aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas correspondentes – **como é o caso da parte autora, considerando que é aposentada pelo INSS recebe mensalmente o valor de R$ 1.100,00 (evento 1, CHEQ5).**

Nessa direção, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento recente, proferido sob o rito do art. 543-C do anterior Código de Processo Civil:

*RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. **O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.** (RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015).*

Além disso, tal tema foi inúmeras vezes objeto recorrente em julgamentos realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente ora colacionado:

> *Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. **Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde.** Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). Grifei.*

Registre-se que não se descuida das discussões travadas no intuito de delimitar os contornos da soliedariedade passiva entre os entes públicos, no tocante ao fornecimento de medicamentos. Entretanto, recentemente o STJ afetou os Conflitos de Competência 187.276, 187.533 e 188.002 como representativos da controvérsia, instaurando Incidente de Assunção de Competência, tendo como objetivo analisar se, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, o autor pode escolher contra qual deles mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas, mas devidamente registrado na Anvisa – o que pode afetar a competência para o julgamento da causa.

Além disso, o IAC instaurado também busca decidir se, nessas demandas, é devida, ou não, a inclusão da União no polo passivo, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.

Ocorre que, no julgamento da questão de ordem suscitada nos conflitos em análise, a Primeira Seção determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual se abstenha de praticar qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

Portanto, ao menos até que se decida o IAC supracitada, não há o que se falar em inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal.

Superada a questão atinente à competência para o julgamento do feito, importa registrar que não se pode admitir que o Judiciário reste inerte no caso de descumprimento da lei, devendo intervir se for impulsionado. Não há, portanto, violação à independência dos poderes quando da concessão de medicamentos judicialmente.

Não fosse por isso, a precária situação no orçamento do Estado não pode justificar a negativa a um direito à saúde, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), que deve prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/RS

> *EMBARGOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA E INCONDICIONADA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. As despesas com a saúde para pessoas carentes devem correr por conta dos recursos destinados ao fundo de desenvolvimento social do estado (Leis Estaduais 9.908/93 e 9.828/93). Saúde é direito de todos e dever do estado e do município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da c. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- rel. Min. Marco Aurélio). O artigo 196 da Constituição Federal não faz distinção entre os entes federados, de sorte que cada um e todos, indistintamente, são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, sendo certo que a descentralização, mera técnica de gestão, não importa compartimentar sua prestação. Embargos acolhidos, por maioria. (Embargos Infringentes Nº 70030244370, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 19/06/2009).*
>
> *AGRAVO. APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público o medicamento necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando o fornecimento de medicamentos a necessitado, devendo responder pelos medicamentos pleiteados no processo. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação ao Município, sendo a Defensoria Pública um órgão do Estado do Rio Grande do Sul e a ação ajuizada também contra Município, ausente confusão entre credor e devedor. Agravo desprovido. (Agravo Nº 70039339122, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/11/2010)*

No caso *sub judice,* a parte autora demonstrou a necessidade do medicamento postulado em virtude da patologia apresentada, Adenocarcinom de Próstata, estagio clínico IV, patologia codificada sob CID 10 C61, conforme laudo médico do evento 1, ATESTMED7, que ressalta a necessidade do uso contínuo da medicação ENZALUTAMIDA (nome comercial XTANDI), 160mg ao dia (04 comprimidos de 40 gramas). Insta mencionar que o médico da parte autora frisou que a medicação é a melhor forma de tratamento para o controle da doença citada, não havendo similar no mercado, assim como não há possibilidade de substituição por qualquer outra, sendo o único que apresenta benefícios para o caso do autor.

Ademais, no parecer técnico da SES (Ev. 38, doc. 2), consta que:

> *"Entre os fármacos disponíveis pelo SUS para uso no cenário clínico do paciente (bicalutamida, mitoxantrona), não há nenhum que tenha demonstrado em estudos clínicos aumento de sobrevida após terapia prévia com docetaxel. As demais medicações que poderiam ser substitutivas da enzalutamida nesse momento, garantindo aumento do tempo de vida do paciente são cabazitaxel e abiraterona, nenhuma delas fornecidas pelo SUS. Ressalta-se ainda que não há nenhum estudo clínico com comparação direta entre as mesmas para que possamos inferir que uma é melhor que a outra, ficando a critério do médico assistente a escolha do tratamento mais adequado para o paciente levando em consideração a doença oncológica, comorbidades e perfil de eventos adversos".*

E, no caso da autora, laudo médico que acompanhou a petição inicial demonstra a submissão do paciente a outros tratamentos prévios, realizados de acordo com o estágio da doença. Assim, a conclusão do profissional médico do Estado está em consonância à prescrição do médico assistente da autora.

Ademais, não se pode olvidar do fato de que o médico que acompanha a parte autora tem plena convicção de qual fármaco se adapta melhor ao tratamento clínico em questão. Por seu turno, não produziu o demandado prova capaz de contrapor ao atestado, no sentido de que a autora poderia valer-se de outros tratamentos que não o postulado

Por fim, observando-se o que estabelece o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde[2], de 15/5/2014, ressalto a necessidade do paciente apresentar relatórios médicos periodicamente perante a Secretaria de Saúde.

Dessa feita, procede a presente demanda para, confirmando a tutela de urgência do Ev. 3, determinar que o réu forneça o medicamento ENZALUTAMIDA (nome comercial XTANDI), 160mg ao dia (04 comprimidos de 40 gramas), na quantia indicada nos atestados, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do Estado para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c art. 500, do Código de Processo Civil).

III - Dispositivo (art. 489, inciso III, do Código de Processo Civil)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido deduzido na ação movida por **ARI PAULO SCHMITT** em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para, confirmando a tutela de urgência deferida ao Ev. 3, condenar a parte ré ao fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA (nome comercial XTANDI), 160mg ao dia (04 comprimidos de 40 gramas), na quantia indicada nos atestados, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do Estado para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c art. 500, do Código de Processo Civil). Atente-se ao Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

Sucumbente, condeno o réu ao pagamento da Taxa Única e despesas, além de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, fulcro no artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho desenvolvido e o tempo curto de tramitação da demanda. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA (REsp. nº 1.270.439/PR) a partir da publicação desta decisão, acrescidos de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), a contar da data do trânsito em julgado da sentença.

Diante do ajuizamento da presente demanda após a entrada em vigor da Lei estadual nº 14.634/14, resta o réu isento da taxa única, a teor do artigo 5º, inciso I, isenção que não abarca as despesas processuais (artigo 14 da referida Lei), que deverá restituir em caso de adiantamento pela outra parte, inclusive a título de pagamento da taxa única, fulcro no IRDR 13 do TJ/RS. Ainda, o Estado é isento da condução de Oficial de Justiça (despesa).

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil[3], intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Resta dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recursos repetitivos[4].

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada intimação eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **MARCIO CESAR SFREDO MONTEIRO, Juiz de Direito**, em 4/10/2022, às 17:55:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10026419630v34** e o código CRC **bbe09b90**.

---

1. Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000) ↩
2. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28564:jornada-aprova-45-enunciados-para-auxiliar-em-decisoes-da-justica-na-area-da-saude>. Acesso em: 25/5/2014. ↩
3. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩
4. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 DA CF E 241 DA CE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO, AO FADEP. REDUÇÃO. CABIMENTO. [...].. REEXAME NECESSÁRIO: Descabe reexame necessário quando a sentença estiver pautada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula de Tribunal Superior Competente, consoante determina o parágrafo 3º, do art. 475, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065928178, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 09/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PROSSO, OSTEOBAN, ARTROLIVE E LYRICA. PACIENTE PORTADORA DE POLIARTROSE NÃO ESPECIFICADA E OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA (CID-10 M15.9 E M81.9). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO, FORNECIDO PELO SUS. DESCABIMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. Reexame necessário. 1. Descabe o reexame necessário, porquanto a sentença que determinou o fornecimento de medicamentos está fundada em decisão do plenário do STF. [...]. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066300096, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...].. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066248014, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiç Julgado em 08/09/2015) ↩